

Cambiamento dei concetti, modelli interpretativi e classificazioni — Sintesi

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 05

Questa lezione risponde a una domanda chiave: *come è cambiato il modo in cui la società legge la disabilità?* Dal modello "ripara la persona" al modello "cambia l'ambiente". Hai già le basi — ora mettile insieme.

Il linguaggio rispettoso

- La terminologia segue i modelli interpretativi: **cambia il modello, cambia la parola**
 - **Regola fondamentale:** **la persona viene prima del deficit** → "persona con disabilità", non "il disabile"
 - **Da evitare:** **invalido, handicappato** (come sostantivo), **diversamente abile, portatore di handicap, "il cieco/il sordo"**
 - **Da usare:** **persona con disabilità, persona in situazione di handicap, persona con disabilità visiva/uditiva/motoria**
 - **Diversamente abile** è problematico perché presuppone sempre capacità alternative — non è necessariamente vero
-

La disabilità nel mondo

- Oltre **1 miliardo di persone** con disabilità nel mondo (~15% popolazione mondiale)
- Includendo i familiari: **oltre un terzo dell'umanità** è coinvolto direttamente o indirettamente
- **Gardou** la chiama **"Terza nazione del mondo"** per dimensioni

- Nei paesi con alta speranza di vita: media **8 anni in condizione di disabilità** per persona
- In Svizzera: **1,8 milioni** con disabilità, **70.000 in Ticino** (2024)
- Il numero *cresce* — per invecchiamento, miglioramento cure neonatali, conflitti armati

Evoluzione del termine nel tempo

Periodo	Termine	Concetto
Fine anni '70	Invalido	Riabilitazione e reinserimento lavorativo
Fine anni '80	Handicappato	Integrazione
Fine anni '90	Persona disabile	Partecipazione
Dal 2000	Persona con disabilità	Inclusione come diritto

I modelli interpretativi

Caso pratico: persona su sedia a rotelle non può accedere al seggio elettorale.
Perché?

- **Modello individuale (biomedico):** perché ha un danno alla spina dorsale
- **Modello individuale (funzionale):** perché non può camminare
- **Modello sociale (ambientale):** a causa della scala, una barriera architettonica
- **Modello sociale (diritti umani):** per esclusione sociale e discriminazione

La **Convenzione ONU (CDPD)** adotta la visione sociale: la **disabilità è il risultato dell'interazione** tra persona con menomazioni e barriere ambientali/comportamentali.

Le classificazioni OMS

ICD (ancora in uso — ICD-11)

- Classifica le **cause** delle malattie
- Schema: EZIOLOGIA → PATOLOGIA → MANIFESTAZIONE CLINICA
- **Modello medico/riabilitativo** — non considera le conseguenze nella vita reale

ICIDH (1980)

- Primo strumento che guarda alle **conseguenze** della malattia
- Schema: MALATTIA → MENOMAZIONE → DISABILITÀ → HANDICAP
- **Menomazione**: danno organico/funzionale
- **Disabilità**: perdita di capacità operative conseguente
- **Handicap**: svantaggio vissuto nell'interazione con l'ambiente
- **Criticato perché**: sequenza lineare non sempre vera, linguaggio negativo, non considera abbastanza i fattori ambientali

ICF (2001 — classificazione attuale)

- Classifica il **funzionamento** della persona nel contesto
- **Modello biopsicosociale**: considera persona e ambiente insieme
- Si chiede cosa la persona *può fare*, non solo cosa non riesce a fare
- È preceduto concettualmente dal **PPH** (Processo di Produzione dell'Handicap): **l'handicap è il risultato dell'interazione tra fattori personali e fattori ambientali** — il PPH ha anticipato questa logica, poi recepita dall'ICF nel 2001

I quattro modelli istituzionali (Mainardi 2010)

Due assi: **luoghi** (speciali ↔ ordinari) × **attenzioni** (nessuna ↔ speciali)

Modello	Luogo	Attenzione	Esempio
Esclusione / Ghettizzazione	Speciale	Nessuna	Manicomi storici
Segregazione	Speciale	Speciale	Centri specializzati, istituti
Integrazione	Ordinario	Speciale (eccezionale)	Rampa costruita per uno studente specifico
Inclusione	Ordinario	Normalmente speciale (per tutti)	Rampe in tutti gli edifici pubblici a priori

Non è una scala del bene e del male. Per alcune persone, in certi momenti, la separazione è la risposta migliore alla loro qualità di vita.

Integrazione vs Inclusione — differenza pratica

- **Integrazione:** la persona si adatta al sistema. Misura speciale, eccezionale, negoziata caso per caso. *Nell'ordine delle possibilità.*
- **Inclusione:** è il sistema che si adatta a tutti. Le misure speciali diventano normali per tutta la popolazione.

I rischi dell'inclusione mal applicata

- L'inclusione è la **parola di moda** — usata spesso a sproposito (es. il coro di Sanremo presentato come "inclusivo" ma era segregativo)
 - **L'inclusione come utopia / direzione:** non è uno stato raggiunto, è un orizzonte verso cui tendere. Per alcune categorie ci siamo già avvicinati molto.
 - **Rischio principale:** mettere dentro le persone senza garantire i sostegni nel tempo → si torna all'esclusione mascherata
 - Rimane vigili: inclusione richiede continuità di risorse e attenzioni, non solo l'atto di "aprire le porte"
-

Lingua facile: integrativa o inclusiva?

- **Integrativa** se disponibile solo per chi la richiede (**telegiornale in orari speciali**)
- **Inclusiva** se tutti i testi pubblici fossero sempre in lingua facile (**circolari scolastiche, documenti medici, ecc.**)
- Lo **strumento in sé** è inclusivo; l'utilizzo dipende dal contesto

Da ricordare: - **ICD → ICIDH → ICF:** da "causa della malattia" a "conseguenze" a "funzionamento nel contesto" - **Integrazione = misura eccezionale per la persona; Inclusione = misura normale per tutti** - **La persona prima del deficit:** mai sostantivare la disabilità